UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

INFECTIOLOGIE
Tuberculose miliaire
Avec patient
Sans geste clinique

Nom du rédacteur : Cindy Carlin **Date de rédaction :** 14/01/2024

Situation de départ N° 274 – Prise en charge d'un patient présentant une tuberculose bacillifère

Domaine de compétence n°1 : Synthèse des résultats d'examens paracliniques

Domaine de compétence n°2 : Stratégie de prise en charge

Attendus d'apprentissage de la situation abordée :

1- Identifier les manifestations radiologiques de la tuberculose
2- Prescrire un traitement antituberculeux adapté et mettre en place la surveillance de son efficacité et de sa tolérance

Patient simulé nécessaire à la station : OUI (homme de 56 ans, d'origine roumaine)

Matériel nécessaire à la station

- Mannequin NON
- Brancard OUI
- Table avec 1 chaise (bureau de l'interne), tablette avec résultat de la radio

Exemple d'instructions au patient simulé

Rappel : seules les réponses précisées ci-dessous et les instructions peuvent être verbalisées. Le patient simulé ne doit rien dire d'autre que ce qui est précisé.

Synopsis : Vous avez 56 ans et vous êtes arrivé de Roumanie il y a 1 an. Depuis 3 mois vous présentez des symptômes à type de toux, fièvre et sueurs nocturnes. Vous consultez ce jour aux Urgences de l'hôpital pour altération de l'état général marquée.
Après un interrogatoire et examen clinique complet, l'interne vous a prescrit une radiographie des poumons à réaliser et revient vous voir en vous expliquant les résultats et la prise en charge.

Identité/Contexte (éléments indispensables)	Nom : BALASKO Prénom : Adrian Âge : 56 ans Plombier Vit seul dans un petit appartement en ville, arrivé il y a 1 an de Roumanie
Antécédents	Aucun antécédent connu
Médicaments actuels/ Toxiques	Ne prend pas de médicament Toxiques : tabac actif à 30 PA
Etats d'esprit/ comportement	Posture allongée Douleur : faible Angoisse : modérée Colère : faible Autre : **Asthénie majeure ++**
Déroulement du scénario	Vous êtes allongé sur un brancard dans le box des urgences. Vous avez déjà été examiné et venez de réalisé une radiographie des poumons. Vous attendez le retour de l'interne pour vous expliquer les résultats et la suite de la prise en charge. Lorsque l'étudiant revient vous voir, commencez par : *Ex : "**Alors docteur, qu'est-ce que j'ai ?**"*

	Puis répondez aux questions de l'étudiant (*cf* tableau ci-dessous) et ne dévoilez les informations que s'il vous les demande spécifiquement.
Autres questions à poser au médecin, à quel moment	. Si l'étudiant n'a pas précisé la durée du traitement, demander « Je vais devoir prendre ce traitement toute ma vie ? » . Si l'étudiant n'a pas expliqué les modalités de prise, le patient demande « Quand dois-je prendre les médicaments ? Est-ce qu'il y en a plusieurs ? » . Si l'étudiant n'a pas expliqué les modalités de surveillance, le patient demande « Est-ce que je vais devoir revenir en consultation ? » « Est-ce que je vais devoir refaire des examens ? » . Si l'étudiant n'a pas expliqué les effets secondaires à surveiller, le patient demande « Est-ce qu'il y a des risques avec ces traitements ? »

TUT'ECOS

Vous ne répondrez aux questions suivantes que si l'évalué (étudiant-médecin) vous les pose. Si les questions de l'étudiant-médecin ne sont pas listées ci-dessous, répondre « je ne sais pas ».

Questions éventuellement posées par l'étudiant - médecin	**Réponses à donner par le patient simulé**
Utiliser un vocabulaire simple sans jargon médical *Si les questions sont compliquées le patient doit dire : « Comment ? Je ne comprends pas la question. »*	
Avez-vous des antécédents médicaux ? Avez-vous une maladie du foie/hépatique ? Avez-vous une maladie du rein/insuffisance rénale ?	Je n'ai jamais été malade à ma connaissance. Je n'ai jamais été opéré.
Prenez-vous des médicaments ?	Non.
Avez-vous des douleurs ?	Non, je suis juste très fatigué.
Avez-vous des allergies à des médicaments ?	Non pas que je sache.
Est-ce que vous vomissez ?	Non.
Avez-vous déjà eu la tuberculose ?	Non.

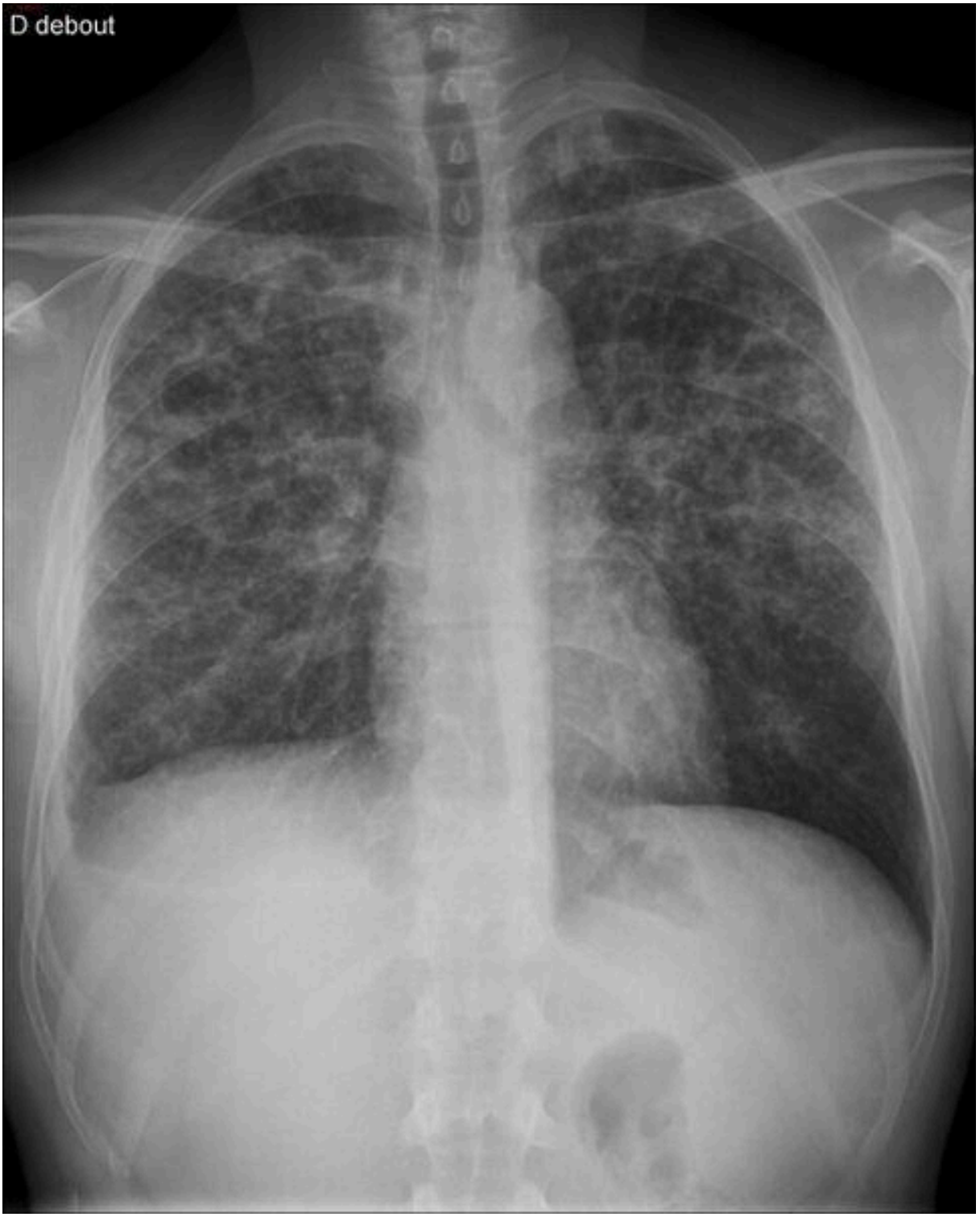
Instructions à l'étudiant

Vous êtes l'interne des urgences pour la journée. Nous sommes au mois de Janvier.

Vous avez reçu dans la matinée M. BLASKO Adrian, un patient d'origine roumaine de 56 ans, pour altération de l'état général récente. Vous avez déjà réalisé un interrogatoire complet qui retrouve une notion de toux chronique avec fièvre et sueurs nocturnes depuis 3 mois, chez un patient tabagique à 30 paquets-année. L'examen physique ne retrouve qu'une asthénie majeure, l'examen pulmonaire est normal.

Vous avez **8 minutes** pour :

1. Donner le nom de l'examen d'imagerie à réaliser en 1ère intention et l'interpréter *(devant l'examinateur)*.
2. Retourner voir le patient à son brancard en lui expliquant le traitement à mettre en place ainsi que la surveillance de son efficacité et de sa tolérance.


D debout

UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

Fiche de correction pour l'évaluateur (sans le barème)

	Cocher si fait
Tâche 1	
L'étudiant indique la nécessité de réaliser une **radiographie pulmonaire** (ou **thoracique** ou **de thorax**) **debout de face** Une fois la 1ère réponse de l'étudiant donnée (qu'elle soit juste ou fausse), vous lui remettez la tablette avec les résultats de l'examen réalisé en disant **« voici les résultats de l'examen qui était demandé »**	
L'étudiant précise qu'il s'agit d'une radiographie pulmonaire (ou thoracique ou de thorax) debout de face.	
Cite la présence d'au moins 2 critères de qualité parmi : visibilité des apex et des culs de sac pleuraux ; visualisation d'au moins 7 arcs costaux antérieurs ; projection symétrique des articulations sternoclaviculaires par rapport à la ligne des processus épineux ; visualisation de la poche à air gastrique.	
Décrit la présence d'opacités micronodulaires bilatérales (ou de grains de mil bilatéraux ou d'une pneumopathie interstitielle diffuse micronodulaire des 2 poumons)	
Décrit la présence d'une hyperclarté (ou excavation) du lobe supérieur droit	
Tâche 2	
Annonce le diagnostic de tuberculose pulmonaire ou miliaire tuberculeuse ou tuberculose miliaire	
Énonce la nécessité d'un traitement par antibiotiques antituberculeux selon le schéma classique pour 6 mois de traitement total : ISONIAZIDE + RIFAMPICINE + ETHAMBUTOL + PYRAZINAMIDE 2 mois suivi de ISONIAZIDE + RIFAMPICINE 4 mois *Tous les points ne sont attribués que si tous les éléments sont dits*	
Explique les modalités de prise : . Prise unique quotidienne . A jeun (sont acceptés : 30min-1h avant le repas ou 2h après)	
Explique les modalités de surveillance de l'efficacité : (OK si 3/3) . Examen clinique répété . Radiographie de thorax répétée . Recherche du bacille de Koch (ou mycobactérie ou BAAR) jusqu'à négativation	
Explique les modalités de surveillance de la tolérance biologique : . Bilan biologique (prise de sang acceptée) toutes les semaines le 1er mois puis tous les 2 mois . Bilan comprenant : NFS-plaquettes, transaminases (enzymes hépatiques acceptées)	
Explique la nécessité d'une consultation ophtalmologique sous ETHAMBUTOL devant le risque de Neuropathie Optique Rétro Bulbaire (atteinte de la vision acceptée)	
Explique la nécessité de l'ajout de vitamine B6 pour prévenir les polynévrites sensitivo-motrices (polynévrite seule acceptée) sous ISONIAZIDE	
Prévient de la coloration orangée des liquides biologiques normale sous RIFAMPICINE	
Prévient de la nécessité d'arrêter le traitement par PYRAZINAMIDE si hépatite (ou augmentation des transaminases > 3N ou augmentation des enzymes hépatiques > 3N) et ISONIAZIDE si > 5N	
COMPÉTENCES GÉNÉRIQUES	
APTITUDE À FOURNIR LES RENSEIGNEMENTS AUX PATIENTS/AUX AIDANTS	1 à 5
APTITUDE À PLANIFIER LES SOINS	
APTITUDE À PROPOSER UNE PRISE EN CHARGE	

UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

Fiche de correction avec le barème : non communiqué à l'évaluateur

	Pondération (entre 1 et 5)
Tâche 1	
L'étudiant indique la nécessité de réaliser une **radiographie pulmonaire** (ou **thoracique** ou **de thorax**) **debout de face**	5
L'étudiant précise qu'il s'agit d'une radiographie pulmonaire (ou thoracique ou de thorax) debout de face.	1
Cite la présence d'au moins 2 critères de qualité parmi : visibilité des apex et des culs de sac pleuraux ; visualisation d'au moins 7 arcs costaux antérieurs ; projection symétrique des articulations sternoclaviculaires par rapport à la ligne des processus épineux ; visualisation de la poche à air gastrique.	1
Décrit la présence d'opacités micronodulaires bilatérales (ou de grains de mil bilatéraux ou d'une pneumopathie interstitielle diffuse micronodulaire des 2 poumons)	3
Décrit la présence d'une hyperclarté (ou excavation) du lobe supérieur droit	3
Tâche 2	
Annonce le diagnostic de tuberculose pulmonaire ou miliaire tuberculose ou tuberculose miliaire	3
Énonce la nécessité d'un traitement par antibiotiques antituberculeux selon le schéma classique pour 6 mois de traitement total : ISONIAZIDE + RIFAMPICINE + ETHAMBUTOL + PYRAZINAMIDE <u>2 mois</u> suivi de ISONIAZIDE + RIFAMPICINE <u>4 mois</u> *Tous les points ne sont attribués que si tous les éléments sont dits*	5
Explique les modalités de prise : . Prise unique quotidienne . A jeun (sont acceptés : 30min-1h avant le repas ou 2h après)	1 (0,5) (0,5)
Explique les modalités de surveillance de l'efficacité : (OK si 3/3) . Examen clinique répété, . Radiographie de thorax répétée, . Recherche du bacille de Koch (ou mycobactérie ou BAAR) jusqu'à négativation	3
Explique les modalités de surveillance de la tolérance biologique : . Bilan biologique (prise de sang acceptée) toutes les semaines le 1er mois puis tous les 2 mois . Bilan comprenant : NFS-plaquettes, transaminases (enzymes hépatiques acceptées)	2
Explique la nécessité d'une consultation ophtalmologique sous ETHAMBUTOL devant le risque de Neuropathie Optique Rétro Bulbaire (atteinte de la vision acceptée)	2
Explique la nécessité de l'ajout de vitamine B6 pour prévenir les polynévrites sensitivo-motrices (polynévrite seule acceptée) sous ISONIAZIDE	1
Prévient de la coloration orangée des liquides biologiques <u>normale</u> sous RIFAMPICINE	1
Prévient de la nécessité d'arrêter le traitement par PYRAZINAMIDE si hépatite (ou augmentation des transaminases > 3N ou augmentation des enzymes hépatiques > 3N) et ISONIAZIDE si > 5N	2
COMPÉTENCES GÉNÉRIQUES	
APTITUDE À FOURNIR LES RENSEIGNEMENTS AUX PATIENTS/AUX AIDANTS	Échelle de 1 à 5
APTITUDE À PLANIFIER LES SOINS	
APTITUDE À PROPOSER UNE PRISE EN CHARGE	